Historia clínica en paciente con dolor agudo postoperatorio o dolor crónico

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Fases y objetivos en la entrevista clínica del paciente con dolor
4. Antecedentes clínicos personales y familiares
5. Aspectos relacionados con el dolor actual
6. Signos de alarma en el paciente con dolor
7. Evaluación de la somatización en la entrevista clínica
8. Bibliografía

Objetivos

- Mostrar al alumno la estructura secuencial para la realización de la entrevista clínica.
- Dar a conocer los aspectos esenciales a registrar tras la entrevista clínica del paciente con dolor.
- Enseñar al alumno a detectar los aspectos sociales, laborales y psicológicos que pueden tener relevancia en la evolución y pronóstico del dolor.
- Enseñar al alumno las nociones básicas de los trastornos de somatización del paciente con dolor.

Introducción

El componente subjetivo del dolor es una de las principales causas para que la entrevista clínica con el paciente, que consulta por dolor, sea del todo imprescindible.

El abordaje del dolor requiere de un enfoque físico y un enfoque emocional, es por ello que la comunicación entre el clínico y el paciente es la base principal para el estudio del dolor, porque estos aspectos tendrán la misma repercusión en el pronóstico y resultado terapéutico que la lesión física en sí misma.

Es por ello que el modelo de entrevista clínica debe permitir una interacción libre del paciente con el clínico, que permita expresar su experiencia en el dolor y las características que acompañen al mismo.

El clínico guiará al paciente tratando de evitar detenerse en aspectos irrelevantes y dirigirá la explicación del paciente hacia aspectos que puedan ayudar a discriminar el origen, los factores agravantes y los signos de alarma lo más precozmente posible *(Figura 1)*.

A continuación, se analiza el enfoque a seguir en la historia clínica del paciente con dolor.

Fases y objetivos en la entrevista clínica del paciente con dolor

La entrevista clínica se define como el proceso de comunicación entre el médico y el paciente con el objetivo de resolver un problema de salud de este último. Los objetivos principales de la entrevista clínica en el paciente con dolor: *(Tabla 1)*.

La entrevista clínica establece las bases de la relación médico-paciente que tendrá un impacto directo en la evolución y el resultado de la intervención por parte del clínico. En el manejo del paciente con dolor hay que tener muy presentes los aspectos emocionales implicados en el dolor a la hora de llevar a cabo la entrevista clínica.

El médico muy a menudo se enfrenta a un paciente cuyo estado de ansiedad, y en otras ocasiones de frustración y depresión, dificulta la relación médico paciente. Por lo tanto, el primer paso de la entrevista clínica es establecer una relación de confianza con el paciente.

Esto se ve favorecido por las entrevistas semiestructuradas que permiten al paciente expresar libremente y describir su experiencia de dolor. La desventaja de estas entrevistas es que se toman más tiempo para realizarlas y que en ocasiones aportan información no relevante para el caso que se estudia.

No obstante, son el método más aplicado para el abordaje del paciente con dolor en el medio[1,2]. Los requisitos para que la entrevista clínica se desarrolle adecuadamente se detallan en la *(tabla 2)*.

Se debe crear un clima adecuado en la consulta, sin interrupciones, donde el médico debe mostrar interés por los datos que transmite el paciente. La comunicación debe ser franca y realista pero no excesivamente directa o alarmante y se debe cuidar tanto del lenguaje verbal como el no verbal. Las cuestiones que se formulan al paciente y la información que transmite el médico deben ser comprensibles para el paciente.

En la parte final de la entrevista el médico debe trasladar al paciente aspectos relevantes acerca del abordaje diagnóstico y terapéutico, informando de los riesgos y beneficios de las pruebas a realizar y de las expectativas de mejoría clínica en su caso.

Antecedentes clínicos personales y familiares

Los antecedentes clínicos del paciente deben ser recabados de forma sistemática en la primera entrevista con el paciente. Es importante incluir la historia previa de alergias a fármacos, asimismo, es fundamental obtener información acerca de posibles adicciones, sean activas o previas como parte de la entrevista con el paciente cuando se aborda el dolor.

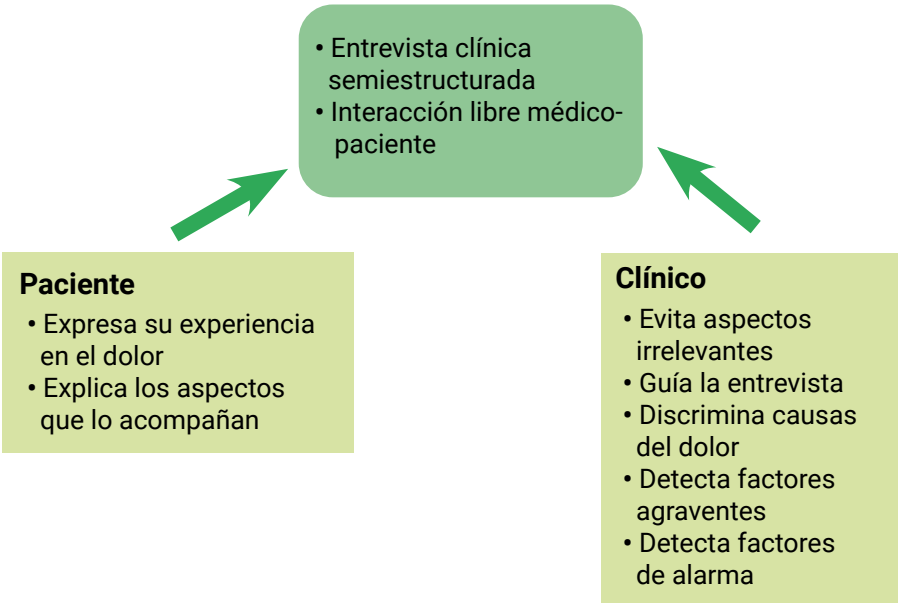

Figura 1. Conceptos entrevista clínica.

Objetivo	Resultado
Establecer una favorable relación médico-paciente	• Creará estado de confianza del paciente. • Disminuirá la ansiedad y frustración. • Permitirá obtener más información. • Favorecerá la adhesión a métodos terapéuticos.
Obtener un diagnóstico del dolor	• Facilitará el abordaje diagnóstico. • Aumentará el éxito de terapias aplicadas.
Definir factores psicológicos del paciente asociados	Permitirá detectar factores que influyen en el pronóstico del dolor.
Definir factores socioambientales del entorno del paciente	• Establecerá bases para la valoración conductual. • Orientará el manejo psicosocial del dolor. • Permitirá detectar factores de riesgo de cronificación y la aplicación de medidas terapéuticas.
Identificar señales de alarma físicos o psicológicos	• Detectar riesgo de cronificación del dolor. • Aplicación de medidas terapéuticas de prevención y tratamiento.

Tabla 1. Objetivos y resultados de la entrevista clínica.

Requisitos de la entrevista clínica
Crear un clima adecuado en la consulta.
Comunicación franca y realista.
Evitar información demasiado directa o alarmante.
Evitar falsas expectativas.
Adecuar la expresión a la capacidad del comprensión del paciente o cuidadores.
Cuidar el lenguaje verbal y no verbal.

Tabla 2. Requisitos para una adecuada entrevista clínica.

Es necesario conocer patologías previas sistémicas del paciente, así como tratamientos crónicos. Los fármacos habitualmente empleados para el manejo analgésico pueden tener contraindicaciones relativas o absolutas en pacientes con patología hepática, renal, cardiopatías o broncopatías.

La aplicación de ciertas técnicas invasivas de empleo para el control del dolor requiere la modificación de tratamientos crónicos tales como antiagregantes o anticoagulantes. Algunos fármacos también pueden desencadenar dolor crónico o modular el efecto de fármacos analgésicos cuando se administran de forma crónica, por lo que es necesario conocer el tratamiento crónico del paciente.

Por otro lado, es muy habitual que la patología previa del paciente esté directamente asociada al origen del dolor. Una anamnesis exhaustiva permitirá aproximar el diagnóstico en caso de dolor visceral, por ejemplo, que tiene un componente de dolor referido frecuentemente, siendo un aspecto muy importante también en el dolor oncológico y en el dolor músculo esquelético.

La historia previa de traumatismos, accidentes o intervenciones quirúrgicas se asocian en gran cantidad de casos con el origen del dolor crónico. De igual manera, la presencia de alteraciones psiquiátricas como depresión o ansiedad se asocian directamente con mayor frecuencia al dolor crónico[3].

Una historia previa de tratamiento por dolor crónico requiere un abordaje específico, porque suelen ser pacientes en los que el riesgo de cronificación del dolor es más alto y existe más dificultad en el tratamiento, dados los fenómenos de secundarismo y de tolerancia a fármacos de estos pacientes.

Dentro de la historia clínica es preciso evaluar los antecedentes familiares, en muchas ocasiones los pacientes con dolor crónico provienen de entorno familiar donde existen otros casos de patología de dolor crónico. Esto se asocia a conductas aprendidas del dolor que aumenta el riesgo de padecer dolor crónico, o a situaciones traumáticas en la infancia como el maltrato o el abuso sexual *(Figura 2)*.

Aspectos relacionados con el dolor actual

Una parte de la entrevista clínica debe ir enfocada a la dolencia principal que tiene el paciente. Es importante discriminar entre las patologías dolorosas del paciente y cuál es la que se tratará. Los aspectos esenciales a determinar son:

- **La localización:** de manera habitual, la localización del dolor agudo es más clara que en el dolor crónico y suele estar directamente asociada con el origen de éste.

  En el dolor crónico la localización del dolor y, sobre todo su asociación con su origen es más compleja. En el dolor crónico interfieren aspectos emocionales, psicológicos, fisiopatológicos que alteran la capacidad de discriminar la localización y su origen.
- **La intensidad del dolor:** el dolor agudo suele ser más lancinante e intenso, genera una limitación intensa de la actividad básica del paciente de este modo altera funciones básicas cotidianas. No obstante, esta limitación suele responder bien al tratamiento farmacológico y revierte habitualmente en corto espacio de tiempo.

  El dolor crónico, por su parte, se caracteriza por niveles de intensidad menores pero que, continuados en el tiempo, provocan una gran limitación funcional y afectación psicológica grave.

  En ocasiones el dolor crónico se acompaña del dolor irruptivo con características similares al dolor agudo y con buena respuesta a tratamiento habitualmente. No obstante, la intensidad del dolor crónico dependerá en gran medida del tipo del dolor que se trate, sea somático, visceral o neurógeno.
- **La cualidad del dolor:** el tipo de dolor y la sintomatología que describe el paciente es muy subjetiva. En ocasiones la descripción del dolor es muy clara, como el caso del dolor dorso lumbar o dolor agudo postoperatorio.

  No obstante, el paciente en muchas ocasiones es incapaz de describir el tipo de dolor o el síntoma principal del mismo; se trata de sensaciones desconocidas que no pueden asociarse a otras experiencias previas, es el caso del dolor neuropático, que requiere una dirección más clara por parte del aclínico experto en el dolor para definir la sintomatología principal del mismo.
- **La evolución cronológica del mismo:** para establecer una clasificación del dolor y un pronóstico de éste es esencial conocer cuándo comenzó el dolor en sí, esto permitirá clasificarlo en dolor agudo, subagudo y crónico. Por otro lado, es esencial abordar la evolución del mismo y la manifestación temporal del dolor.

  En este sentido, el dolor puede ser continuo, intermitente, fluctuante o irruptivo. En la mayoría de las ocasiones, varios tipos de presentación del dolor coexisten en un mismo caso y estas diferentes manifestaciones del dolor deben ser abordadas de forma específica, además, la información que transmite el paciente es esencial para obtener los datos necesarios en este aspecto.

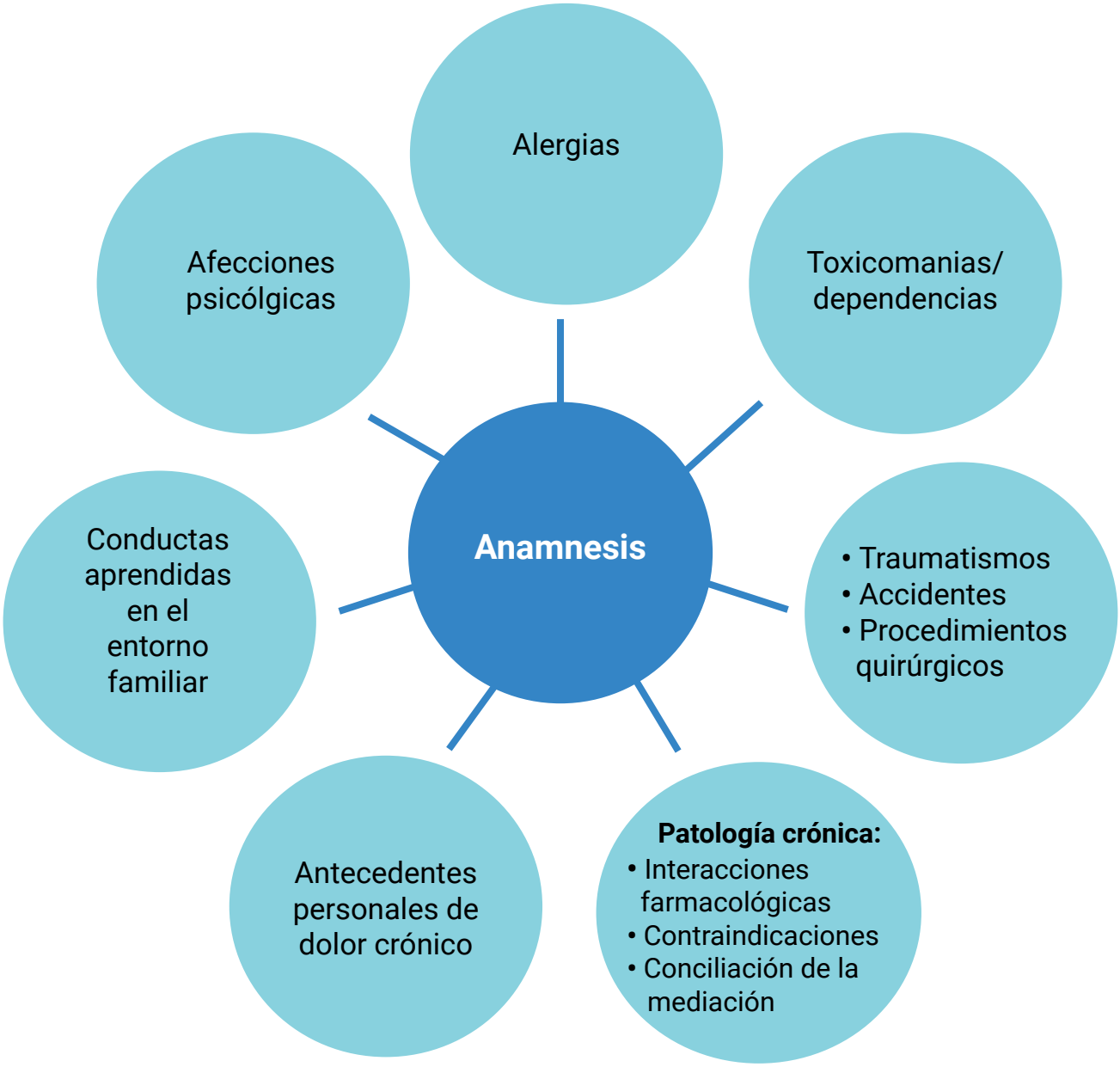

Figura 2. Anamnesis en la historia de dolor.

- **Factores atenuantes y provocativos del dolor:** en la entrevista clínica el paciente podrá indicar aspectos que se relacionan con el dolor y que permitirán acercarse a la etiología del mismo. En este punto resulta muy efectivo dejar explicar al paciente, de forma libre, los aspectos que empeoran y mejoran su dolor.

  En la mayoría de las ocasiones, los pacientes han desarrollado conductas evitativas y atenuantes del dolor. Muchas de ellas han generado nuevos problemas de dolor y a menudo por sobrecarga postural.

  Este aspecto es además importante en los pacientes con dificultades de comunicación y en pacientes infantiles, en estos casos, las conductas asociadas aportan la información que el clínico necesita para el abordaje correcto del dolor.

  En este momento conviene abordar también el tratamiento que el paciente está llevando a cabo y la respuesta al mismo. Los datos obtenidos de esta parte de la historia clínica permitirán en gran medida establecer una clasificación del mismo y, sobre todo, permitirán discriminar entre dolor agudo y crónico, y, en muchas ocasiones, permitirá detectar signos de alarma de éste *(Tabla 3)*.

Signos de alarma en el paciente con dolor

La entrevista clínica es el momento idóneo para establecer la sospecha de un origen maligno o de algún proceso clínico que requiera tratamiento prioritario para evitar secuelas en el paciente. Si bien el dolor crónico no suele ser la primera manifestación de una patología potencialmente maligna, se deben seguir buscando los signos de alarma en los pacientes.

	Dolor agudo	Dolor crónico
Localización	• Bien localizado • Asociada al origen	• Difícil de localizar • No asociado al origen
Intensidad	Lancinante	Sordo
Limitación de actividades habituales	• Intensa • Normalmente poco duradera	• Moderada • Prolongada en el tiempo
Respuesta al tratamiento	Habitualmente responde	Responde mal al tratamiento

Tabla 3. Aspectos relacionados con el dolor actual.

Esto debe hacerse no sólo en la primera entrevista sino en las revisiones sucesivas, debido a que la evolución del dolor, las características del mismo y la respuesta a diferentes terapias o la modificación de las mismas puede indicar que la evolución del dolor es potencialmente maligna.

En el caso del dolor musculoesquelético, sea agudo o crónico, existen una serie de factores clínicos que harán sospechar de una patología de base potencialmente severa *(Figura 3)*.

El término acuñado como *banderas rojas,* incluido en la clasificación de banderas clínicas, se emplea fundamentalmente para el dolor musculoesquelético, y se trata de signos, síntomas o circunstancias clínicas del paciente que asocian el dolor a una situación clínica infecciosa, inflamatoria, oncológica que requiere un estudio y manejo prioritario. No obstante, el término *banderas rojas* se emplea de forma habitual en otros tipos de dolor como la migraña o el dolor visceral *(Tabla 4).*

Los signos de alarma en migraña son[4,5] cefalea intensa de comienzo agudo o empeoramiento reciente de cefalea crónica. También, cefalea unilateral (excepto en cefalea en racimos, hemicránea paroxística, neuralgia trigeminal, hemicránea continua), cefaleas con síntomas acompañantes (fiebre, signos meníngeos, náuseas y/o vómitos) o en pacientes oncológicos o inmunodeprimidos y dolor visceral. Se presenta en edades extremas o de predominio nocturno (salvo la cefalea en racimos).

Los signos de alarma en dolor visceral son: deposiciones hemáticas, pérdida de peso, dolor que despierta por la noche, dolor localizado en cuadrantes derechos, distensión abdominal, efecto masa o megalias, fiebre o síndrome miccional, que en estos casos indicará un estudio más completo y rápido mediante pruebas complementarias.

- **Factores psicológicos:**

  En toda entrevista clínica, enfocada al dolor agudo o crónico, deben tenerse muy en cuenta los aspectos emocionales y psicológicos del dolor, de modo que una parte de la entrevista debe ir dirigida a explorar al paciente en estos términos. Especialmente en el caso del dolor crónico el enfoque precisa de un manejo interdisciplinar que incluya el manejo psicológico.

  El estado emocional del paciente puede ser una consecuencia del padecimiento de dolor, teniendo en cuenta que está demostrado que el dolor puede activar o agravar estados psicopatológicos presentes en el paciente[3].

  Después de una extensa revisión de la literatura sobre este tema, se concluye, de forma similar a Serrano y cols[2], que el estado emocional puede ser un agravante del dolor, e incluso el origen del dolor, siendo los casos de dolor psicógeno algunos de los más complejos a los que se enfrenta un clínico experto en dolor *(Figura 4)*.

  En la evaluación clínica del paciente se debe estar atento a la presencia de signos de alarma de origen emocional. Son las llamadas *banderas amarillas,* incluidas en el grupo de banderas psicosociales.

  La presencia de *banderas amarillas* es indicativa de que la recuperación puede no ser la esperada para el tipo del dolor por motivos psicológicos o emocionales, entre las banderas amarillas se incluyen aspectos relacionados con las creencias previas sobre el dolor y el tratamiento, respuestas emocionales al dolor ansiedad, depresión y conductas ante el dolor, aislamiento o actitud pasiva ante el dolor *(Figura 5).*

- **Factores sociales y laborales**

  Los factores sociales que envuelven al paciente están muy a menudo implicados en el control del dolor y deben ser conocidos en la historia clínica del paciente. Es fundamental detectar los factores sociales y ambientales que pueden ensombrecer el pronóstico del dolor.

Tumor	Fractura	Infección
• Antecedentes de tumor • Anorexia/pérdida de peso • No alivio con reposo • Mal estado general • >50 años	• Traumatismo intenso • Osteoporosis • Mujer • Esteroides • > 50 años	• Fiebre • Adicción a drogas parenterales • Esteroides • Postcirugía • Infección previa

Figura 3. Factores asociados a patologia potencialmente severa.

Banderas rojas		
Dolor músculo-esquelético	**Migraña**	**Dolor visceral**
Inicio en <20 o > 50 años	Cefalea aguda intensa	• Deposiciones hemáticas • Sangrado ginecológico
Traumatismo reciente	Empeoramiento de cefalea crónica	Distensión abdominal
Dolor constante con evolución tórpida	Cefalea unilateral (salvo síndromes típicamente unilaterales)	Afectación principalmente en cuadrante derecho
Antecedentes personales de enfermedad tumoral maligna	Síntomas clínicos acompañantes (fiebre, sintomas meningeos)	
Uso prolongado de esteroides	Paciente inmunodeprimido	
Empleo de drogas por vía parenteral	• Paciente oncológico • Edades extremas	
Astenia		Astenia
Fiebre		Fiebre
Anorexia y pérdida de peso		Anorexia y pérdida de peso
Deformidad axial evidente		
Masas		Masas, megalias
Alteraciones vasculares, neurológicas		Síndrome miccional
	Predominio nocturno	Predominio nocturno

Tabla 4. Banderas rojas en dolor musculoesquelético, migraña y dolor visceral.

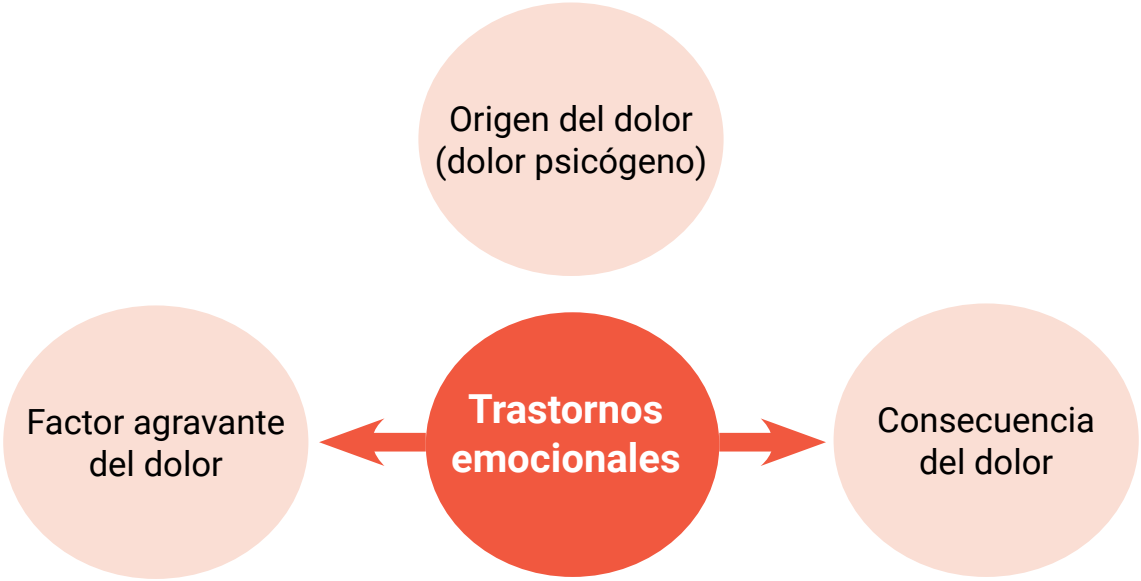

Figura 4. Factores psicológicos y dolor.

Figura 5. Banderas psicosociales amarillas.

En este contexto se establecen las *banderas azules*, que se emplean en el contexto laboral del paciente e incluye las expectativas del paciente en cuanto a su capacidad para desarrollar su trabajo habitual, la insatisfacción laboral o la mala relación con los compañeros y empleadores o la percepción de que el trabajo puede estar resultando nocivo para su dolor.

Este tipo de banderas pueden ser modificadas por el paciente y por el entorno médico que lo apoya. Por otro lado, están las *banderas negras* que también se incluyen en la evaluación del entorno laboral del paciente, pero que depende de factores ajenos al mismo e incluye políticas de empresa, normativa y situaciones en el entorno laboral que dificulta la adaptación y la rehabilitación del trabajador.

En el aspecto socio laboral del paciente es necesario conocer la afectación económica que el dolor está teniendo sobre el entorno familiar y la posibilidad de existencia de litigios legales relacionados con el dolor, por ejemplo, la situación de espera de incapacidad *(Tabla 6)*.

- **Factores moduladores del dolor**

  Como se ha señalado previamente, el dolor es una percepción sensorial que se ve modificada por muchos factores. Estos factores pueden ser físicos o psicológicos y deben ser analizados en el contexto de la historia clínica, entre los más estudiados hasta el momento se encuentran factores dependientes del individuo y factores dependientes del entorno:

  - *Rasgos de personalidad:* múltiples estudios han tratado de establecer una relación entre los aspectos de la personalidad y la presencia de dolor crónico, como es el caso de los rasgos hipocondriacos, o los rasgos ciclotímicos.

    Según parece, la personalidad no está relacionada directamente con la presencia de dolor crónico sino con los aspectos psicológicos negativos asociados al mismo como el sufrimiento o la discapacidad. De este modo, parece haber una relación directamente proporcional en el nivel de neuroticismo y el nivel de dolor[6,7].

  - *Apoyo social y relación con otras personas familiares, amigos y compañeros de trabajo:* el apoyo social al paciente con dolor tiene una relación directamente proporcional con la disminución del grado de cronificación del dolor y del grado de discapacidad física y socio laboral del paciente.

    El apoyo social está relacionado con una mejora de la adaptabilidad a las circunstancias asociadas al dolor y un afrontamiento de la situación efectivo. Es por esto que tiene un papel relevante en la capacidad de adaptación a acontecimientos vitales en la situación del dolor[8,9]. El apoyo social en términos de fortalecimiento del afrontamiento activo, la autoafirmación, la distracción y la búsqueda de información en los profesionales de la salud.

  - *Sexo y edad:* la edad y el sexo de los pacientes parece tener un impacto relevante en la percepción del dolor y la cronificación de éste[10]. Así, según el estudio realizado por Ramírez[6], en 2001, los niveles de alteración emocional, sensorial, evaluativa y afectiva son superiores en las mujeres, más que en los hombres.

    En cuanto a la edad, son los pacientes de mayor edad los que presentan mayor alteración emocional del dolor, mientras que, en los pacientes jóvenes, las puntuaciones en el test de McGill fueron superiores en el componente sensorial.

    Actualmente, la información con respecto a la influencia de la edad y el dolor es contradictoria, existen estudios que establecen que el umbral del dolor es superior en adultos de mayor edad, aunque existen otros trabajos con la conclusión opuesta[11,12].

  - *Nivel cognitivo:* dolores previos y aprendizaje de experiencias previas. Múltiples autores han establecido relación entre la probabilidad de sufrir dolor crónico y la presencia de antecedentes personales traumáticos importantes, como el maltrato o el abuso sexual[13].

    Si bien en la actualidad la relación no está clara, se entiende que los traumas infantiles contribuyen a una menor capacidad de afrontamiento de problemas en el futuro, asociado a conceptos de inferioridad, baja autoestima y de apego[13-15].

    Por otro lado, las conductas aprendidas en la infancia confieren gran parte de la actitud ante el dolor que tendrá el paciente en un futuro. Se conoce que los pacientes, cuyos progenitores han sufrido dolor crónico, tienen dolor crónico con más frecuencia.

    Además, se sabe que las relaciones de apego seguras que viven los pacientes en la infancia disminuyen el riesgo de padecer dolor crónico, probablemente esto esté asociado a la mejora de la eficiencia de técnicas de afrontamiento de estas personas[16] *(Figura 6 y 7)*.

Evaluación de la somatización en la entrevista clínica

La somatización se podría definir de forma general como las quejas físicas que ocasionan malestar, en ausencia de hallazgos clínicos que permitan justificar una causa orgánica. Las somatizaciones están incluidas en los trastornos somatomorfos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Banderas azules	Banderas negras
Entorno laboral del paciente.	Entorno laboral del paciente.
Pueden ser modificadas por el individuo.	No pueden ser modificadas por el individuo.
• Expectativas sobre la posibilidad de realizar el trabajo . • Relación con los compañeros/empleadores. • Percepción de impacto del trabajo en su dolor. Insatisfacción laboral.	• Políticas de empresa. • Normativas.

Tabla 6. Banderas psicosociales azules y negras.

Rasgos de personalidad: hipocondríacos, ciclotímicos	Se asocian a factores moduladores negativos: sufrimiento o discapacidad.
Mujeres	Mayor nivel de alteración: emocional, sensorial, evaluativa y afectiva.
Edad	• **Mayores:** alteración emocional. • **Jóvenes:** alteración sensorial.

Figura 6. Factores individuales moduladores del dolor.

Nivel cognitivo	Apoyo y relaciones sociales
• Factores de riesgo de dolor crónico: - Traumas infantiles (maltrato, abusos) - Dolor crónico en el entorno familiar - Poco apego familiar	• Fortalecen afrontamiento • Mejora la autoestima • Favorece la adaptabilidad • Diminuyen riesgo de dolor crónico

Figura 7. Factores moduladores del dolor dependientes del entorno.

La somatización es un problema clínico con un componente experiencial, conductual y cognitivo. El dolor crónico se presenta muy frecuentemente como una forma de somatización de trastornos psicológicos tales como la ansiedad, la depresión o experiencias traumáticas. En estos casos no se encontrará un origen físico que justifique el dolor.

No obstante, el dolor por somatización es una realidad clínica que se debe detectar a tiempo, debido a que el manejo precoz mejora el pronóstico y evita complicaciones y fenómenos de cronificación.

Para el diagnóstico del dolor psicógeno es necesario descartar patología física de base, lo cual requiere la evaluación cuidadosa del paciente. La entrevista clínica en este tipo de paciente es esencial, ya que es preciso que el paciente establezca una relación de confianza adecuada para afrontar el diagnóstico y el enfoque terapéutico.

Asimismo, es muy importante discriminar y diferenciar el dolor derivado de la somatización de otros tipos de dolor que pueda presentar el paciente, ya que muy frecuentemente coexisten otras patologías con sintomatología dolorosa.

De manera habitual, el dolor que describe el paciente es errático, con características muy peculiares y variables y no se encuadra fácilmente en patologías clínicas frecuentes. Habitualmente, son pacientes que recurren asiduamente a fármacos psicótropos o presentan dependencias a alcohol u otras drogas.

Con gran frecuencia sufren un gran deterioro de su vida laboral y social, y el dolor no responde a fármacos habituales. Además, existen una serie de aspectos que pueden hacer sospechar de la presencia de somatización[17] *(Figura 8)*.

La solicitud de pruebas diagnósticas debe ser muy enfocada a descartar patologías potencialmente malignas o que pueden generar un daño importante al paciente si no reciben tratamiento. Sin embargo, es necesario sopesar los riesgos de las pruebas diagnósticas, considerando que una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de pacientes es la iatrogenia.

En segundo lugar, la entrevista clínica debe ir enfocada a la detección de una patología o entidad psicológica que pueda ser el origen del dolor. En este aspecto puede ser necesaria la participación en el diagnóstico de especialistas en enfermedades psicológicas/psiquiátricas.

El manejo del dolor psicógeno se basa en terapias psicológicas, entre ellas la técnica de reatribución de Goldberg[18], las terapias cognitivo-conductuales y las técnicas de relajación pueden tener efectividad (grado de recomendación B), siendo el manejo farmacológico secundario.

En el dolor somatomorfo los antidepresivos son eficaces, más los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina) que los ISRS (grado de recomendación B). Hay que intentar evitar la administración de analgésicos opioides y medicaciones potencialmente adictivas (grado de recomendación C) *(Tabla 7)*.

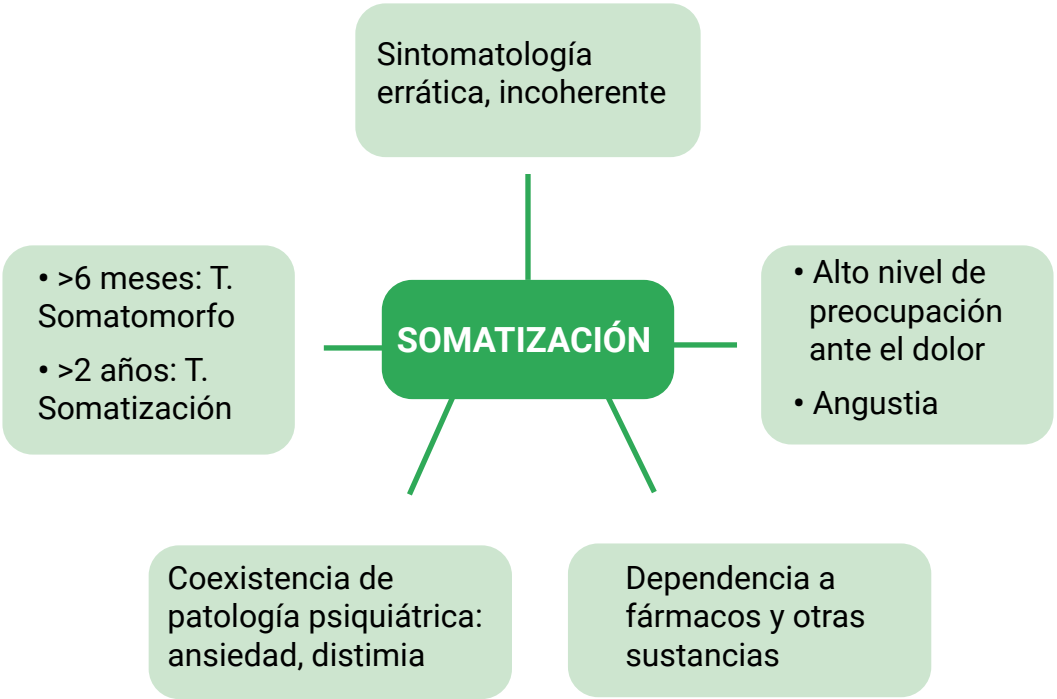

Figura 8. Características de trastornos somatomorfos y de somatización.

Terapia	Efectos	Grado de recomendación
• Técnicas retribución de Goldberg. • Técnicas de relajación. • Terapias cognitivo-conductuales.	Efectivos.	B
Antidepresivos.	Efectivos.	B
• Opioides. • Ansiolíticos.	• Evitarlos. • Riesgo de dependencia.	C

Tabla 7. Manejo terapéutico de los trastornos somatomorfos y de somatización.

Bibliografía

1. Serrano Atero MS, Caballero J, Cañas A. Valoración del dolor (I). Rev Soc Esp Dolor 2002; 9:94-108.
2. Serrano Atero MS, Caballero J, Cañas A, García Saura PL. Valoración del dolor (II). Rev Soc Esp Dolor 2002; 9:109-121.
3. Dersh J1, Polatin PB, Gatchel RJ. Chronic pain and psychopathology: research findings and theoretical considerations. Psychosom Med. 2002 Sep-Oct;64(5):773-86.
4. Actitud diagnóstica y terapéutica en la cefalea. Recomendaciones 2006. Grupo de Estudio de Cefalea. Barcelona: Ergon S.A.; 2006.
5. Heras Pérez JA, editor. Guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas 2009. Grupo de Estudio de Cefaleas. Sociedad Andaluza de Neurología.
6. Ramírez, C. A., López, E, Esteve, R.,. Evaluación de estrategias de afrontamiento, nivel de funcionamiento y edad en personas con dolor oncológico y benigno. Rev.Soc. Esp. Dolor2001. 8: 102-110.
7. Paredes A., Gladys y Pinelo Navarro B. Neuroticismo, afrontamiento y dolor crónico. Revista de Psicología [online]. 2013, n.10 [citado 2019-11-09], pp. 23-33. Disponible en:<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322013000200003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2223-3032.
8. Vinaccia S, Quiceno J, Fernández H, Contreras F, Bedoya M, Tobón S, et al. Calidad de vida, personalidad resistente y apoyo social percibido en pacientes con diagnóstico de cáncer pulmonar. Psicología y Salud. 2005;15(2):207-220.
9. Coob S. Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine.1976;38:300-314.
10. Ramírez Maestre C, Esteve R, López-Martínez A, Anarte Mª. Diferencias en la percepción del dolor relacionada con las variables sexo y edad. Rev Soc Esp Dolor 2001; 8: 562-568.
11. Gagliese L, Melzack R. The assessment of pain in the elderly. En: Mostofsky DI, LJ. Handbook of Pain and Aging. Nueva York: Plenum Press, 1997.
12. Collin G, Stone LA. Pain sensitivity, age and activity level in chronic schizofrenics and in normals. BritishJournal of Psychiatry 1966; 112: 33-55.
13. Green CR1, Flowe-Valencia H, Rosenblum L, Tait AR The role of childhood and adulthood abuse among women presenting for chronic pain management. Clin J Pain. 2001;17(4):359-64.
14. N. Sachs-Ericsson, K. Cromer, A. Hernandez, K. Kendall-Tackett. A review of childhood abuse, health, and pain-related problems: the role of psychiatric disorders and current life stress. J Trauma Dissociation. 2009;10(2):170-88.
15. K. Raphael, H. Chandler, D. Ciccone Is Childhood Abuse a Risk Factor for a Chronic Pain in Adulthood Current Pain and Headache Reports, 8 (2004), pp. 99-110.
16. Mark A. Lumley, Jay L. Cohen, Francis J. Kafe. Pain and Emotion: A Biopsychosocial Review of Recents Research J. Clin. Psychol., 67 (9) (2011), pp. 942-968.
17. Abordaje de los problemas de salud mental: Trastornos somatomorfos en Atención Primaria. Disponible en: http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2005/temas/tema5-6/trastornos.php
18. Salud mental en Atención Primaria. Trastorno somatomorfo. Disponible en: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/bfb8d2a8-0f04-11de-9de1-998efb13096d/S_MENTAL4.pdf